Dr. Diego Zubieta
Médico · CRM/SP 246.697

Plano de _____

Data _____

PLANO PESSOAL · BASEADO EM DBT

Quando a dor ficar *grande demais*, siga este plano, um passo de cada vez.

Emoções intensas sobem como uma onda e também descem. O objetivo aqui não é resolver tudo agora, é atravessar os próximos minutos sem fazer nada que piore a situação. Preencha com calma, num momento tranquilo, e deixe à mão.

0–3 · DESCONFORTO	4–7 · AFLIÇÃO ALTA	8–10 · CRISE
Use as habilidades do dia a dia: rotina, sono, movimento, conversar.	Comece pelo passo 1 e vá descendo. Habilidades de distração e autoacalmar.	Corpo primeiro (TIP), ambiente seguro e busque alguém agora.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Reconheça os sinais gatilhos, pensamentos, sensações no corpo

Perceber cedo dá mais escolhas. O que costuma vir antes da crise?

2 STOP: não aja no impulso

S Pare
Congele. Não reaja, não responda, não decida nada.

T Afaste-se
Dê um passo para trás. Saia do lugar, respire.

O Observe
O que está acontecendo dentro e fora de mim?

P Prossiga
Com atenção: o que me ajuda de verdade agora?

3 TIP: acalme o corpo para a mente acompanhar para aflição 8 a 10

T Temperatura
Água bem fria no rosto (ou bolsa de gelo nos olhos e bochechas) por 15–30 s, prendendo o ar. Ativa o reflexo de mergulho e desacelera o coração.

I Exercício intenso
10–20 min: correr, subir escadas, polichinelos. Gasta a energia que a emoção acumulou no corpo.

P Respiração ritmada
Inspire em 4, segure em 4, solte o ar em 6, por 3 a 5 min. A expiração mais longa reduz o estresse.[4,5]

P Relaxamento pareado
Ao inspirar, contraia um grupo muscular por 5 s; ao soltar o ar, relaxe e diga "solta". Rosto, ombros, mãos, pernas.

Água fria não é indicada para quem tem doença cardíaca, arritmia, pressão baixa ou transtorno alimentar sem orientação médica.

4 Distraia-se e acalme os 5 sentidos

O que funciona para mim? (ex.: banho, música, cheiro de café, mascar gelo, jogo, sair para caminhar, segurar algo macio)

5 Fale com alguém pessoas e lugares que me ajudam

Nome / telefone _____

Nome / telefone _____

Lugar seguro _____

Profissional _____

Se houver risco à vida, *não espere.*

Vá ao pronto-socorro mais próximo ou ligue agora. Consulta agendada e telemedicina não são serviço de urgência.

188
CVV · apoio emocional 24h, gratuito · cvv.org.br

192
SAMU · emergência médica

UPA
ou pronto-socorro mais perto:

_____

PASSO 6 EM DIANTE

Atravessar a onda *sem piorar* a situação.

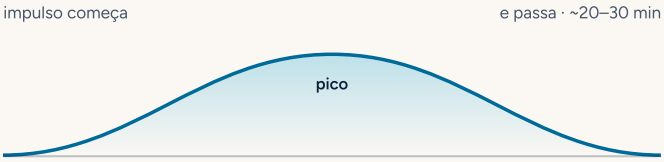
Deixe o ambiente seguro

Afastar o acesso a meios de se machucar é uma das medidas mais eficazes na crise.[6] Ela ganha tempo, e o tempo faz a onda baixar.

- Peça a alguém de confiança para **guardar remédios** e deixar só o da semana.
- Tire de perto objetos cortantes, álcool e outras substâncias.
- Vá para um lugar com outras pessoas.

Surfe a urgência

Impulsos atingem um pico e passam, mesmo sem você agir. Observe a vontade como uma onda: nomeie ("estou sentindo vontade de..."), note onde ela fica no corpo e respire até ela descer.



Prós e contras

Antes de agir no impulso, pense no que vem depois.

Agir no impulso · prós	**Agir no impulso · contras**
Resistir · prós	**Resistir · contras**

Aceitação radical

Brigar com a realidade soma sofrimento à dor. Aceitar não é concordar nem desistir: é reconhecer o que é, para conseguir escolher o próximo passo.

- *"Isso é o que está acontecendo agora."*
- *"Não posso mudar este momento, mas posso atravessá-lo."*
- *"Já passei por momentos difíceis antes."*

Meus motivos para *continuar*

Pessoas, projetos, lugares, coisas que ainda quero viver.

Depois que a onda passar

- **Cuide do corpo:** coma, beba água, tente dormir. Cansaço, fome e álcool deixam a emoção mais forte.
- **Seja gentil consigo:** ter uma crise não é fracasso; usar o plano já é uma vitória.
- **Anote** o que disparou e o que ajudou, e leve para a próxima consulta.
- **Revise este plano** sempre que algo mudar.

EM QUE ESTE PLANO SE BASEIA

Combina o **plano de segurança** (sinais de alerta, estratégias próprias, contatos, ambiente seguro), associado a cerca de **43% menos** comportamento suicida em meta-análise,[2] com as **habilidades de tolerância ao mal-estar da DBT**.[1] Intervenções focadas em regulação emocional, como a DBT, reduzem tentativas e ideação suicida.[3,7] Ele complementa o tratamento, não o substitui.

1. Linehan MM. *DBT Skills Training Manual*. 2ª ed. Guilford Press; 2015.
2. Nuij C, et al. Safety planning-type interventions for suicide prevention: meta-analysis. *Br J Psychiatry*. 2021;219(2):419-426. doi:10.1192/bjp.2021.50
3. Saccaro LF, et al. Emotion regulation-targeted interventions initiated during hospitalization for suicidal crisis: systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*. 2026;403:121375. doi:10.1016/j.jad.2026.121375
4. Fincham GW, et al. Effect of breathwork on stress and mental health: a meta-analysis of RCTs. *Sci Rep*. 2023;13:432. doi:10.1038/s41598-022-27247-y
5. Pilcher JJ, et al. Brief slow-paced breathing improves working memory, mood, and stress. *Anxiety Stress Coping*. 2025;38(5):528-543. doi:10.1080/10615806.2025.2505897
6. Trott M, et al. Suicide methods and severe mental illness: systematic review and meta-analysis. *Acta Psychiatr Scand*. 2024;151(4):467-484. doi:10.1111/acps.13759
7. Kothgassner OD, et al. Efficacy of DBT for adolescent self-harm and suicidal ideation: meta-analysis. *Psychol Med*. 2021;51(7):1057-1067. doi:10.1017/S0033291721001355

Dr. Diego Zubieta
(19) 99141-2825 · drdiegozubieta.com.br
Médico · CRM/SP 246.697 · Residente em Psiquiatria (Instituto Bairral), **não especialista**.

Material educativo de apoio ao tratamento. Em emergência: **CVV 188** · **SAMU 192**.